

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA - CARDIOLOGÍA

HISTORIA CLÍNICA - CONSULTA EXTERNA DE CARDIOLOGÍA

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre completo: José Antonio Ramírez López
Edad: 62 años
Sexo: Masculino
Fecha de nacimiento: 15/03/1962
Nacionalidad: Mexicana
Ocupación: Jardinero
Estado civil: Casado
Escolaridad: Secundaria completa
Fecha de consulta: 20/06/2024
Número de expediente: HTA-2024-0845

II. MOTIVO DE CONSULTA

"Me duele la cabeza y he tenido mareos en las últimas dos semanas.
En la farmacia me tomaron la presión y me dijeron que estaba muy alta."

III. ENFERMEDAD ACTUAL (INTERROGATORIO)

Paciente masculino de 62 años que acude a consulta refiriendo cefalea occipital de intensidad moderada a severa (escala EVA 7/10) de aproximadamente 15 días de evolución. Refiere que el dolor es pulsátil, empeora por las mañanas y cede parcialmente con analgésicos de venta libre (paracetamol 500 mg).

Adicionalmente, refiere episodios de mareo no vertiginoso, sensación de visión borrosa intermitente y acúfenos (zumbido en oídos) bilaterales. Niega dolor torácico, palpitaciones, disnea o edema en extremidades.

El paciente refiere que en una farmacia cercana le realizaron una medición de presión arterial hace 3 días, reportando 165/98 mmHg. Se recomendó acudir a valoración médica.

=====

=====

IV. ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS

=====

=====

- Hipertensión arterial diagnosticada: Hace 8 años (2016)
- Diabetes mellitus tipo 2: Diagnosticada hace 5 años (2019)
- Dislipidemia: Diagnosticada hace 3 años (2021)
- Obesidad: IMC 31.2 (obesidad grado I)
- Tabaquismo: 30 años, 1 cajetilla/día (abandonó hace 2 años)
- Consumo de alcohol: Ocasional (fines de semana, 2-3 cervezas)

=====

=====

V. ANTECEDENTES FAMILIARES

=====

=====

- Padre: Fallecido a los 68 años por Infarto Agudo al Miocardio, hipertenso
- Madre: Viva, 84 años, hipertenso
- Hermano mayor (70 años): Hipertenso y diabético
- Hermano menor (58 años): Hipertenso

=====

=====

VI. MEDICACIÓN ACTUAL

=====

=====

- Losartán 50 mg: 1 tableta cada 12 horas
- Metformina 850 mg: 1 tableta cada 8 horas
- Aspirina 100 mg: 1 tableta al día
- Simvastatina 20 mg: 1 tableta al día (no toma regularmente)

ADHERENCIA: Refiere no ser adherente a la medicación. "Se me olvida tomar las pastillas" y "a veces las dejo porque me siento bien".

=====

=====

VII. EXPLORACIÓN FÍSICA

=====

=====

Fecha de exploración: 20/06/2024

SOMATOMETRÍA:

- Peso: 92 kg
- Talla: 1.72 m
- IMC: 31.2 kg/m² (Obesidad Grado I)
- Perímetro abdominal: 106 cm

SIGNOS VITALES:

- Presión arterial: 168/102 mmHg (Brazo derecho, sentado)
- Presión arterial: 165/100 mmHg (Brazo izquierdo, sentado)
- Frecuencia cardíaca: 88 latidos por minuto
- Frecuencia respiratoria: 18 respiraciones por minuto

- Temperatura: 36.6°C
- Saturación O2: 96% (Aire ambiente)
- Presión arterial media: 124 mmHg

EXPLORACIÓN GENERAL:

- Paciente consciente, orientado en tiempo, espacio y persona
- Buen estado general, regular estado nutricional (obeso)
- Mucosas orales hidratadas, rosadas
- No hay palidez ni ictericia

EXPLORACIÓN CARDIOVASCULAR:

- Inspección: No se observa ingurgitación yugular, no deformidad torácica
- Palpación: Pulsos periféricos conservados y simétricos. Ictus no desplazado
- Auscultación: Ruidos cardíacos rítmicos, no soplos. Segundo ruido conservado
- No se auscultan galopes ni roces

EXPLORACIÓN RESPIRATORIA:

- Inspección: Tórax normoexpandible
- Palpación: Vibraciones vocales conservadas
- Percusión: Sonoridad pulmonar normal
- Auscultación: Murmullo vesicular conservado, no crepitantes ni sibilancias

EXPLORACIÓN ABDOMINAL:

- Abdomen globoso, blando, depresible
- No doloroso a la palpación superficial ni profunda
- No se palpan masas ni visceromegalias
- Ruidos intestinales presentes, normales

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA:

- No déficit motor ni sensitivo
- Marcha normal
- Reflejos osteotendinosos conservados
- Fondo de ojo: Se observan cambios compatibles con retinopatía hipertensiva (estrechamiento arteriolar, cruces arteriovenosos patológicos)

=====

VIII. RESULTADOS DE LABORATORIO

=====

FECHA DE MUESTRA: 19/06/2024

BIOQUÍMICA:

- Glucosa: 168 mg/dL (Valor normal: 70-100)
- Hemoglobina glicosilada: 7.8% (Valor normal: <7%)
- Creatinina: 1.3 mg/dL (Valor normal: 0.6-1.2)
- Nitrógeno ureico (BUN): 22 mg/dL (Valor normal: 7-20)
- Ácido úrico: 6.8 mg/dL (Valor normal: 3.4-7.0)
- Sodio: 138 mEq/L (Valor normal: 135-145)
- Potasio: 4.2 mEq/L (Valor normal: 3.5-5.0)

PERFIL LIPÍDICO:

- Colesterol total: 228 mg/dL (Valor normal: <200)

- LDL: 152 mg/dL (Valor normal: <100)
- HDL: 38 mg/dL (Valor normal: >40)
- Triglicéridos: 190 mg/dL (Valor normal: <150)

HEMOGRAMA:

- Hemoglobina: 14.2 g/dL (Valor normal: 13-17)
- Leucocitos: 7,500/mm³ (Valor normal: 4,500-11,000)
- Plaquetas: 220,000/mm³ (Valor normal: 150,000-450,000)

EXAMEN DE ORINA:

- pH: 5.5
- Densidad: 1.020
- Proteínas: Ausentes
- Glucosa: 100 mg/dL (microalbuminuria)
- Sedimento: Normal

ESTUDIOS DE IMAGEN:

- Electrocardiograma: Ritmo sinusal, signos de hipertrofia ventricular izquierda (criterios de voltaje de Sokolow-Lyon)
- Radiografía de tórax: Índice cardiotorácico elevado, silueta cardíaca compatible con hipertrofia ventricular izquierda

IX. DIAGNÓSTICO

PRINCIPAL:

1. Hipertensión arterial sistémica no controlada (Estadio 2)
 - Presión arterial: 168/102 mmHg

DIAGNÓSTICOS SECUNDARIOS:

2. Diabetes mellitus tipo 2 mal controlada (HbA1c: 7.8%)
3. Dislipidemia mixta (Hipercolesterolemia + Hipertrigliceridemia)
4. Obesidad Grado I (IMC: 31.2)
5. Hipertrofia ventricular izquierda (por ECG y Rx de tórax)
6. Retinopatía hipertensiva incipiente
7. Enfermedad renal crónica en estadio 2 (Creatinina: 1.3, eGFR: 58 mL/min)

X. PLAN DE TRATAMIENTO

FARMACOLÓGICO:

1. Aumentar Losartán: De 50 mg a 100 mg cada 12 horas (dosis máxima)
2. Agregar Amlodipino: 5 mg cada 24 horas
3. Metformina: Mantener 850 mg cada 8 horas
4. Agregar Empagliflozina: 10 mg cada 24 horas (control glucémico y renal)
5. Atorvastatina: Aumentar de 20 mg a 40 mg cada 24 horas
6. Ácido acetilsalicílico: Mantener 100 mg cada 24 horas

NO FARMACOLÓGICO:

1. Dieta hiposódica (reducir sal a <2 gramos/día)
2. Dieta hipocalórica (para pérdida de peso)
3. Ejercicio: Caminata 30 minutos diarios, 5 días a la semana
4. Control y reducción de peso: Objetivo perder 5-10 kg en 6 meses
5. Suprimir consumo de alcohol
6. Adherencia estricta a medicación programada
7. Automonitoreo de presión arterial dos veces al día
8. Control glucémico con glucometro (ayuno y posprandial)

=====

=====

XI. INDICACIONES AL PACIENTE

=====

=====

- Debe tomar sus medicamentos exactamente como se indicó
- Reducir consumo de sal en todos los alimentos
- Evitar alimentos procesados y enlatados
- Realizar ejercicio moderado diariamente
- Llevar registro de presión arterial y glucosa
- Asistir a control en 2 semanas
- Acudir a urgencias si presenta: dolor de pecho, dificultad para respirar, pérdida de conciencia o dolor de cabeza muy intenso
- Mantener seguimiento con oftalmólogo por retinopatía
- Control con nefrólogo por función renal

=====

=====

XII. FIRMA DEL MÉDICO

=====

=====

Dr. Miguel Ángel Fernández Herrera
Cédula profesional: 2345678
Especialista en Cardiología - Medicina Interna
Hospital Clínico Universitario
Teléfono: (55) 5555-1234
Correo: cardiologia@hospitaluniversitario.mx

=====

=====

FECHA DE EMISIÓN: 20 de junio de 2024

=====

=====